TEMA 8 · Enfermería basada en la evidencia, guías y vías clínicas. Igualdad, violencia de género y derechos LGTBI

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: EBE, fuentes, búsqueda, lectura crítica, niveles de evidencia, GPC, mapas y vías clínicas · Bloque B: LO 3/2007, Ley 7/2007, LO 1/2004 y Ley 4/2023

A1. Concepto y modelos de implementación de la EBE

- Origen: Medicina Basada en la Evidencia, **Universidad de McMaster** (años 90; **Sackett** y Guyatt): "utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia disponible".
- **Gálvez Toro (Fundación Index)**: 4 componentes: **investigación**, **experiencia clínica**, **preferencias del paciente** y **recursos disponibles**.
- Fases (5 A): **Ask** → **Acquire** → **Appraise** → **Apply** → **Assess**.

Modelo	Claves
Iowa (Titler)	**Organizacional**; arranca con **desencadenantes (triggers)**: **del problema** (datos internos: caídas, bacteriemias, quejas) o **del conocimiento** (nueva GPC, normativa externa); prueba piloto en una unidad
Stetler	**Individual** (pensamiento crítico de la enfermera); 5 fases: preparación, validación, evaluación comparativa, aplicación y evaluación
ACE Star (Stevens)	5 puntas: descubrimiento, resumen, traslación (guías), integración y evaluación
Joanna Briggs (JBI)	Australia; ciclo de generación, síntesis, transferencia y utilización

TRAMPAS DE EXAMEN

! Desencadenante interno (aumento de caídas) = **enfocado en el problema**.

! Cambio individual basado en un artículo = **Stetler**, no Iowa.

A2. Preguntas, fuentes y bases de datos

- Preguntas **background** (básicas: qué, cómo, por qué) → fuentes **terciarias** (libros). Preguntas **foreground** (decisión clínica) → formato **PICO** y bases de datos.
- Formatos: **PICO**/PICOT/PICOS (eficacia), **SPIDER** (cualitativa; su "E" es **evaluación**) y **PECO** (riesgo/etiología; su "E" es **exposición**).

Fuente	Qué es	Ejemplos
Primaria	Estudio original	ECA, cohortes, casos y controles
Secundaria	Sintetiza fuentes primarias	**Revisiones sistemáticas, metaanálisis, GPC**
Terciaria	Conocimiento consolidado	Libros, enciclopedias, diccionarios

- **Literatura gris**: tesis, actas de congresos, informes; se busca en las revisiones sistemáticas para evitar el **sesgo de publicación**.

Base de datos	Claves
PubMed/MEDLINE	NLM (EE. UU.); tesauro **MeSH** (inglés)
Cochrane Library	Revisiones sistemáticas (CDSR) y registro CENTRAL
WoS / Scopus	Citas y factor de impacto
CINAHL	La mayor específica de **enfermería**
LILACS / BDENF	Latinoamérica / enfermería de Brasil; tesauro **DeCS** (trilingüe)
CUIDEN	**Fundación Index (Granada)**; mucha literatura gris y cualitativa

Base de datos	Claves
ENFISPO	Universidad **Complutense**: enfermería, fisioterapia y podología
Dialnet / MEDES / CUIDATGE	La Rioja / Fundación Lilly / Rovira i Virgili

- **Metabuscadores**: **Trip Database** (resultados por colores) y **Epistemonikos** (Chile, revisiones sistemáticas). **Gestores bibliográficos**: Mendeley, Zotero, EndNote.
- Búsqueda: **AND** (restringe), **OR** (amplía), **NOT** (excluye); **truncamiento *** (enferm*), **comodín ?** (p?ediatrics), comillas (frase exacta), etiquetas [ti], [ab], [au], y paréntesis: dolor AND (niños OR neonatos). **Operadores de proximidad** (no booleanos): NEAR, ADJ, NEXT.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Las GPC son fuentes secundarias, no primarias.**

! MeSH = PubMed. DeCS = LILACS/BDENF.

A3. Lectura crítica, revisiones sistemáticas y metaanálisis

- Lectura crítica: **validez** interna, **importancia** de los resultados y **aplicabilidad**.
- **CASPe** (de CASP, Oxford): plantillas por diseño, de 10-11 preguntas en 3 bloques: **A, validez** (las **2 primeras** son de **eliminación**), **B, resultados**, **C, aplicabilidad**. Es una herramienta del **lector**; las guías de redacción para autores son CONSORT, STROBE, PRISMA o COREQ.
- **Revisión sistemática**: método explícito y reproducible (frente a la revisión **narrativa**, subjetiva). **Metaanálisis**: combina estadísticamente los resultados.
- **PRISMA 2020** (sustituye a PRISMA 2009 y antes a QUOROM): **27 ítems** y diagrama de flujo de **4 fases**: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión. Extensiones: PRISMA-P (protocolo, registro en PROSPERO), PRISMA-ScR (scoping reviews).
- **Forest plot**: cada estudio es un cuadrado (tamaño = peso) con su intervalo de confianza; el **diamante** es el resultado global. Línea de no efecto: **1** para RR/OR y **0** para diferencias de medias. Si el IC **toca o cruza** esa línea, no es significativo.
- **Funnel plot**: la **asimetría** indica **sesgo de publicación**.

A4. Niveles de evidencia y grados de recomendación

Sistema	Claves
Jovell y Navarro-Rubio (1995)	**9 niveles** (I ECA grande ... IX anecdótico) y grados **A-E**. **C = evidencia insuficiente**; **E = buena evidencia para excluir** (es dañino)
CTFPHC (Canadá, prevención)	A buena a favor, B moderada a favor, C conflictiva, D moderada en contra, E buena en contra, **I insuficiente**
SIGN (usado por GuíaSalud)	Niveles 1++ a 4 (los "−" no sirven para recomendar); grados **A-D** y √ buena práctica clínica
GRADE (OMS, Cochrane)	ECA parten de **alta**, observacionales de **baja**; bajan por sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión o sesgo de publicación; suben por efecto grande (RR > 2 o < 0,5; muy grande si > 5 o < 0,2), dosis-respuesta o confusión residual. Calidad alta, moderada, baja o muy baja. Recomendación **fuerte** o **débil/condicionada**
CEBM Oxford	Niveles 1 a 5 con subniveles (1a RS de ECA, 1b ECA, 1c "todo o nada") y grados A-D
JBI (FAME)	**F**easibility (viabilidad), **A**ppropriateness (adecuación), **M**eaningfulness (significado para el paciente), **E**ffectiveness

TRAMPAS DE EXAMEN

! En Jovell, la **E** no es "insuficiente": significa **desaconsejar** por daño.

! "Viabilidad, adecuación, significado" = **JBI**.

A5. Integración en la práctica y herramientas de estandarización

- **Barreras**: del profesional (resistencia, idioma, falta de tiempo), de la organización (sobrecarga, falta de liderazgo y acceso) y de la propia evidencia (resultados ambiguos). **Modelo KTA** (Graham): creación del conocimiento y ciclo de acción.

Herramienta	Responde a	Ámbito	Flexibilidad
GPC	**¿Qué hacer?**	Nacional (**GuíaSalud**)	Alta
Vía clínica	**¿Cuándo y quién?**	Hospital o servicio; **multidisciplinar**	Media (registra variaciones)
Mapa de cuidados	Plan enfermero estandarizado	Lenguaje **NANDA-NOC-NIC** en la HCE (Selene, OMI-AP)	—
Protocolo / procedimiento	**¿Cómo hacerlo?**	Unidad; unidisciplinar	**Nula** (obligatorio)

- **GPC (IOM)**: recomendaciones elaboradas sistemáticamente para ayudar a profesionales y pacientes a decidir. **GuíaSalud**: organismo del **CISNS**, con centro coordinador en el **Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud**.
- **AGREE II**: **23 ítems en 6 dominios** (alcance y objetivos; participación de los implicados; **rigor en la elaboración**; claridad; aplicabilidad; independencia editorial), escala **Likert de 1 a 7**, **2-4 evaluadores** independientes y 2 ítems globales.
- **Vía clínica**: para procesos de **alta frecuencia**, alto riesgo o coste y **evolución predecible** (prótesis de cadera o rodilla, colecistectomía programada, parto eutócico). Componentes: **matriz temporal**, **hoja de variaciones**, **hoja de información al paciente** y **encuesta de satisfacción**.

CLAVE PARA RECORDAR

- Números: PRISMA **27** ítems; AGREE II **23** ítems y **6** dominios; CASPe **10-11** preguntas.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Si el paciente con vía clínica tiene fiebre, la vía **no se suspende**: se anota en la **hoja de variaciones**.

BLOQUE B · Igualdad, violencia de género y derechos LGTBI

B1. LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

- Persigue la igualdad **real y efectiva** (más allá del art. 14 CE). Principio rector: **transversalidad**.

Concepto	Definición	Ejemplo
Discriminación directa (art. 6.1)	Trato menos favorable por razón de sexo	"Solo enfermeros varones para el turno de noche"
Discriminación indirecta (art. 6.2)	Norma **aparentemente neutra** que perjudica a un sexo sin justificación	Exigir 1,75 m de altura para la UCI; disponibilidad total a quien no tenga cargas familiares

- **Art. 8**: el trato desfavorable por **embarazo o maternidad** es discriminación **directa**. **Art. 9**: **indemnidad** frente a represalias por reclamar. **Art. 10**: nulidad de los actos discriminatorios; **inversión de la carga de la prueba**. **Art. 11**: **acciones positivas** (razonables, proporcionadas y mientras dure la desigualdad).
- Riesgo durante el embarazo y la lactancia (art. 58): adaptación → cambio de puesto → suspensión con el 100%. **Vacaciones** (art. 59): se disfrutan en otro periodo si coinciden con estos permisos, aunque haya terminado el año.
- **Permiso por nacimiento (RDL 6/2019)**: **16 semanas** para cada progenitor, **individual e intransferible**, al 100%; las **6 primeras** tras el parto son **obligatorias** e ininterrumpidas; las otras 10 se distribuyen hasta los 12 meses.
- **Planes de igualdad (art. 46; RD 901/2020)**: obligatorios con **50 o más trabajadores** (o si lo exige el convenio o la autoridad laboral). Diagnóstico negociado de **9 materias** (selección, clasificación, formación, promoción, condiciones,

auditoría retributiva, corresponsabilidad, infrarrepresentación y **acoso**). Inscripción en registro público; **Distintivo de Igualdad**.

- **Empleo público (Título V)**: Unidades de Igualdad y **presencia equilibrada** (D. A. 1.ª): ningún sexo **por encima del 60% ni por debajo del 40%**.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Planes de igualdad: **50** trabajadores (250 y 100 son cifras antiguas).
>
> ! Las semanas del permiso por nacimiento **no se pueden ceder** al otro progenitor.
>
> ! Tribunal de 5 miembros: como máximo **3** del mismo sexo.

B2. Ley 7/2007 de Murcia y II Plan de Igualdad del SMS

- Transversalidad en planificación, presupuestos, ejecución y evaluación; **Instituto de la Mujer** como organismo gestor.
- **Acoso (art. 22)**: **acoso sexual** (naturaleza sexual) y **acoso por razón de sexo** (desprecio por ser mujer, por embarazo). Ambos son **discriminación directa** y **falta muy grave**. Protocolo del SMS: denuncia confidencial, comité investigador paritario con prevención de riesgos, **medidas cautelares**, informe y equipos de apoyo a la víctima.
- **Art. 25 · salud**: integrar la perspectiva de género es **obligatorio**: datos desagregados por sexo, sesgos diagnósticos (infarto en la mujer), programas específicos y formación en violencia de género.
- **II Plan de Igualdad del SMS**: plantilla de alrededor de **70% mujeres** con techo de cristal persistente; **10 ejes**. Destacan el **eje 5** (conciliación y corresponsabilidad) y el **eje 6** (**especial protección**: traslados urgentes y adaptación de jornada para víctimas de violencia de género **sin merma retributiva**).

B3. LO 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género

- **Art. 1**: violencia de un **hombre** sobre una **mujer** que sea o haya sido su **cónyuge o pareja**, **aun sin convivencia**. Incluye violencia física, psicológica (también **luz de gas**), sexual, económica y **vicaria** (art. 1.4). Las agresiones de desconocidos se rigen por otras normas (p. ej., libertad sexual).
- **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**: competencia **penal y civil** (divorcio, custodia, pensiones).
- **Art. 15**: formación sanitaria para el diagnóstico precoz. **Art. 16**: **Comisión contra la Violencia de Género del CISNS** (protocolos e indicadores).
- **Art. 19**: asistencia social integral (información, atención psicosocial, asesoría jurídica, acogida); **19 bis**: atención sanitaria integral.
- **Derechos laborales (arts. 21-26)**: reducción o reordenación de jornada, **movilidad geográfica sin necesidad de vacante**, suspensión con reserva de puesto y **faltas justificadas** por informe de servicios sociales o sanitarios.

Protocolo común sanitario

1. **Detección**: hematomas en distintos estadios, lesiones defensivas, lesiones en el embarazo, ITS o embarazos no deseados repetidos, somatizaciones, ansiedad, depresión, consumo de psicofármacos; acompañante que no se separa y responde por ella.
2. **Entrevista**: en **privado**, separándola con una excusa (ECG, constantes), sin juicios ni presión.
3. **Valoración del riesgo**: **riesgo vital** → no dejarla salir, avisar a las fuerzas de seguridad (112, 091, 062) y parte de lesiones; **violencia aguda sin riesgo inminente** → **parte de lesiones** al Juzgado de Guardia aunque no quiera denunciar (relato literal entre comillas); **violencia crónica** sin lesión aguda → apoyo y derivación a trabajo social.

- Recursos en Murcia: **CAVI** (psicóloga, abogada y trabajadora social; **sin necesidad de denuncia**), **EMAVI** (municipales: acogida, empleo), **016** (24 h; no aparece en la factura, pero hay que **borrarlo del móvil**) y **112** (emergencias).

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! **Agresión de una expareja sin convivencia = sí es violencia de género según la LO 1/2004.**

B4. Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad de las personas trans y los derechos LGTBI

- **Despatologización**: persona trans = identidad sexual distinta del sexo asignado al nacer.
- **Autodeterminación (art. 16)**: acceso a la atención sanitaria y a tratamientos de afirmación de género **sin diagnósticos psiquiátricos** ni informes de "disforia".
- **Donación de sangre y tejidos**: prohibida la exclusión por orientación o identidad; solo por **conductas de riesgo individuales** con base científica.
- **Art. 17**: **prohibidas las terapias de conversión**, **incluso con consentimiento** del interesado; es infracción **muy grave**.
- **Art. 18**: acceso equitativo a la **reproducción asistida** y enfoque no heteronormativo.
- **Art. 19 · personas intersexuales**: **< 12 años**: **prohibida** la modificación genital, salvo indicación médica para proteger la salud física; **12-16 años**: solo a **petición expresa del menor** y con madurez certificada (no basta la voluntad de los padres).
- Infracción por **victimización secundaria** (trato inadecuado o trabas). Formación obligatoria del personal.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Menores intersexuales: la barrera es **12 años**, no los 16 de la mayoría de edad sanitaria.